

Répertoire Dermato
Juin 2023

Q1

Question 1

Patiente de 48 ans qui présente ces lésions depuis quelques mois. Quelle est la lésion élémentaire ?



- (A) papules formant une plaque annulaire
- (B) vésicules à disposition linéaire
- (C) pustules en bouquet
- (D) bulles formant une plaque nummulaire
- (E) nodule tumoral

Réponse : A) papules formant une plaque annulaire

Question 2

↗ >60 ans

Patient de 80 ans qui présente ces lésions depuis quelques semaines. Quels autoanticorps sont classiquement associés à cette maladie ?



(A)

collagène VII

(B)

(40-60 ans)

desmoglein 1

→ Pemphigus vulgaire

(C)

(>60 ans)

BP180

→ Hémiplasmose → Pemphigôïde bulleux

(D)

(20-40 ans)

transglutaminase

→ Dermatite herpétiforme

(E)

anticorps anti-nucléaires

Session

Quicktest

Question type:

Multiple Choice

Réponse : C) BP 180

Ce n'est pas un pemphigus mais une pemphigôïde bulleuse car les bulles sont bien tendues et bien rondes.

Autres :

Pas le collagène 7 : correspond à épidermoïte bulleuse.

Maladies auto-immunes bulleuses :

Characteristics	Bullous pemphigoid	Pemphigus vulgaris	Dermatitis herpetiformis
Epidemiology	- Peak incidence > 40 years of age - Most common bullous autoimmune disease	Peak incidence 40-60 years of age	Peak incidence 15-40 years
Etiology	- Type II hypersensitivity reaction - Autoantibodies against BP180	- Type II hypersensitivity reaction - IgG antibodies directed against desmoglein 3 and desmoglein 1 - Exacerbating factors: drugs, stress, UV radiation, diet	- Most likely genetic predisposition to autoimmune reaction (associated with HLA-DQ2 and HLA-DQ8) - Associated with celiac disease and sensitivity to potassium iodide (e.g., contrast medium)
Clinical findings	- A prodromal stage with formation of urticarial lesions may occur weeks to months before onset of blistering - Large, tense, subepidermal blisters on normal, erythematous, or eczematous skin - Intensely pruritic lesions, possibly hemorrhagic, heal without scar formation - Distributed on palms, soles, lower legs, groin, and genital - Oral involvement is rare	- Progression in stages - Spontaneous onset of painful flaccid, intraepidermal blisters - Lesions rupture and become crusted - crusting and crusts - re-epithelialization with hyperpigmentation but without scarring - Pruritus is typically absent - Lesions typically first present on the oral mucosa (> 50% of cases), then on body parts exposed to pressure (e.g., intertriginous areas)	- Tense, grouped subepidermal vesicles, papules, and/or bullae (herpetiform appearance) - Intense pruritus - Bilateral, symmetrical distribution, commonly over elbows, knees, buttocks, shoulders, scalp - No mucosal involvement
Autoantibodies against	- BP180 (BP230) - BP230 (BP180)	Desmoglein 3 and desmoglein 1	- Tissue transglutaminase - Epidermal transglutaminase - Endomysium
Tranck test	Negative	Positive	Negative
Nikolsky sign	Negative	Positive	Negative
Diagnostics	- Intraepidermal vesicle formation - Subepithelial vesicle formation - Immunofluorescence: deposition of linear IgG and C3 along the dermo-epidermal junction	- Intraepidermal vesicle formation just above the basal layer of the epidermis - Acantholysis - biopsy: loss of intercellular connections between keratinocytes (fence of tonofilaments' appearance) - Deposition of IgG in the intercellular spaces of the epidermis - early lesion - Immunofluorescence: deposition of IgG in a reticular pattern around endothelial cells	- Subepidermal vesicle formation - Nonspecific papillary microabscesses - Deposition of granular IgA in dermal papillae
Treatment	- First-line: high-dose topical steroids (clobetasol, betamethasone) - Second-line: systemic glucocorticoids and immunosuppressants (e.g., methotrexate, azathioprine)	- First-line: high-dose systemic steroids (prednisone) - Immunosuppression (e.g., azathioprine, mycophenolate) - Topical treatment	- First-line: dapsone - Gluten-free diet - Topical steroids may be adjunctively used to control severe pruritus - Low dietary intake of iodine
Prognosis	Benign disease, usually responds well to treatment	Often fatal without treatment	Usually a lifelong condition requiring continuous treatment and dietary adjustments

In bullous pemphigoid, antibodies attack the hemidesmosomes located below the epidermis.

Q3

Question 3

Patient de 35 ans, qui présente ces lésions sur les mains, montre sa bouche et vous voyez une **lésion herpétique** au niveau de la lèvre inférieure. Quel est le diagnostic le plus probable ?



- (A) herpès
- (B) **érythème polymorphe**
- (C) lichen plan
- (D) granulome annulaire
- (E) mycose

(Hypersens. IV)

P 502463

Session Quickstart

Question type:

Multiple Choice

Réponse : B) érythème polymorphe

Lésion en cible ou cocarde, subdivisée en **3 cercles**, avec **centre nécrotique**, 2^{ème} cercle un peu **œdématié, blanchâtre**, puis **inflammation autour (3^{ème} cercle)**.

Étiologie : **HSV** et **médicaments**.

Q4

Question 4

Patiente de 31 ans qui présente ces lésions depuis quelques jours qui sont **très prurigineuses** et **migratrices**. Quelle serait votre proposition thérapeutique de première ligne ?



→ Urticaire

- (A) corticoïdes topiques
- (B) rétinoïdes
- (C) inhibiteurs de calcineurine
- (D) immunosuppresseurs
- (E) **antihistaminiques**

Réponse E : Antihistaminiques

Probablement **urticaire**, lésions papulo-maculeuses entourées de plaques blanchâtres.

Peu de pathologie en dermato montrent une clinique **migratrice** de la sorte.

Ne pas utiliser de corticoïdes topiques car hypersensibilité type I IgE médiée, avec excès d'histamines.

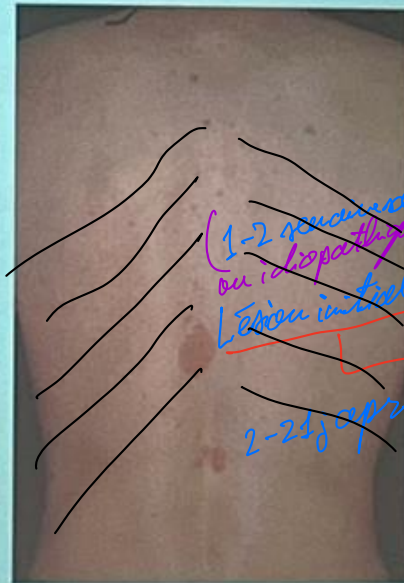
Autres :

Ex d'inhibiteur calcineurine = tacrolimus, alternative aux corticoïdes. Indications : dermatose auto immune.

Q5

Question 5

Patiente de 27 ans qui présente des lésions érythémateuses et papuleuses arrondies ou ovalaires, annulaires, disposées sur le **tronc** avec une **colerette desquamative**. Lésion initiale que vous voyez au centre de la photo **précède de quelques jours** l'apparition des autres lésions. Quelle serait votre proposition diagnostique ?



- (A) syphilis
- (B) toxidermie
- (C) lupus érythémateux
- (D) **pityriasis rosé de Gibert**
- (E) primo-infection VIH

Réponse : D) pityriasis rosé de Gilbert.

Lésion typique en médaillon, qui apparaît quelques jours avant les autres lésions généralisée. Disposition en sapin de Noël.

Etiologie : **HHV-7**

Autres :

Pathologie dermo du au **HHV-8** = **Sarcome de Kaposi**.

Le délai de la **syphilis** est plus long. Lésion initiale = **chancre**.

Primo infection VIH : lésion élémentaire = **rash maculo-papuleux**.

Q6

Question 6

Patient de 15 ans qui présente depuis quelques jours une lésion annulaire prurigineuse, faite de microvésicules érythémateuses et squameuses avec extension centrifuge. Quel examen complémentaire demanderiez-vous pour confirmer votre hypothèse diagnostique ?



- (A) examen direct des squames par blankophor = KOH
- (B) sérologie syphilitique
- (C) recherche des anticorps antinucléaires
- (D) biopsie
- (E) tests épicutanés

Réponse : A Examen direct des squames par blankophor.

Penser à mycose (dermatophytes), autres champignons possible = candida (levure).

Tinea
Corporis
Terbinafine (topique)
(ou Azoles)

Q7

Question 7

Patient de 75 ans qui présente depuis quelques jours des lésions **croûteuses** de taille variable disposées sur le front et la paupière supérieure de façon **unilatérale**. Les lésions élémentaires primaires visibles sont des **vésicules regroupées**. Quel est votre hypothèse diagnostique ?



- (A) toxidermie
- (B) eczéma de contact
- (C) photodermatose
- (D) **VZV** → **zona**
- (E) rosacée

*Agglomé (L72h)
ou
(Vesicules)*

Réponse : D

Atteinte unilatérale, suivant le même dermatome

(Chaud, Ot, Stress) → Rosacée : pas d'atteinte croûteuse.

(Métroindazole topique)

Q8

Question 8

Une patiente de 25 ans présente un **érythème** en **vespertillo** du visage. L'examen d'**immunofluorescence directe** de la biopsie cutanée montre)



- (A) une **bande granulaire** au niveau de la **jonction dermo-épidermique**
- (B) une **bande linéaire** au niveau de la **jonction dermo-épidermique** → Pemphigoides bulleux
- (C) un marquage **intra-épidermique** en **maille de filet** → Pemphigus vulgaire
- (D) marquage des **corps cytoïdes** au niveau de la **jonction dermo-épidermique** → Lichen plan, Dermatoses lichénoïdes
- (E) marquage des **vaisseaux du derme superficiel** → Vasculite

Réponse : A Bande granulaire au niveau de la jonction dermo-épidermique.

Le Dx est un **lupus aigu**, faisant des **lésions maculeuses** sur le visage sous forme d'un **papillon**, ou alors en vespertillo. La complication la plus commune = une **atteinte rénale**.

Autres :

Marquage intraépidermique en maille de filet = pemphigus.

Marquage des corps cytoïdes = lichen plan ou des dermatoses lichénoïdes.

Marquage des vvx superficiels = vasculite.

Question 9

Une patiente de 68 ans qui présente une **tuméfaction érythémateux** au niveau de la jambe droite- L'examen clinique révèle une augmentation de la **chaleur** au niveau de la lésion et un **trajet lymphangitique** avec une **mycose interdigitale** du pied droit. Quel est le diagnostic le plus probable ?

↳ Point d'entrée du *S. pyogenes*
(ou *S. aureus*)



- (A) lymphangite
- (B) **dermohypodermite infectieuse**
- (C) périartérite noueuse
- (D) insuffisance artérielle
- (E) thrombophlébite

(Excrépète = tout sortit)
(ttt: Co-Amox
Gpl: Fasciite nécrosant)

Réponse : B Dermohypodermite infectieuse

Différence entre une dermohypodermite infectieuse et une lymphangite bulleuse = dans un dermohypodermite infectieuse, le site de l'infection = derme profond et hypoderme avec présence de germes qui causent l'infection avec secondairement une atteinte lymphangitique. Dans la dermohypodermite infectieuse, on peut trouver la porte d'entrée.

Dans la **lymphangite**, pas d'infection dans les zones profondes de la peau, que les **vx lymphatiques** qui sont atteints.

Q10

Question 10

Un homme de 24 ans en bonne santé habituelle présente depuis 3 jours un état fébrile à 38.5 °C, une pharyngite, des céphalées et un rash cutané maculo-papuleux thoracique. L'examen clinique objective en plus des adénopathies diffuses, légèrement douloureuses. Quel test faut-il pratiquer pour établir le diagnostic?



- (A) dosage des anticorps anti-HBc
- (B) dosage des anticorps anti-VIH *trop tôt (3 sem - 3 mois)*
- (C) mesure de l'ADN de l'hépatite B
- (D) mesure de la virémie de l'hépatite C
- (E) mesure de la virémie VIH

Réponse : E mesure de la virémie VIH

C'est une primo-infection VIH, trop tôt pour mesurer des anticorps, qui apparaissent plutôt entre 3 semaines à 3 mois.

Q11

Question 11

Un homme de 20 ans se présente avec des lésions palmaires non-prurigineuses. Auparavant, le patient a présenté un exanthème passager également non prurigineux. Qu'est-ce qui est indiqué en premier lieu?



- (A) un traitement d'épreuve de courte durée avec une crème à la cortisone
- (B) une culture mycologique
- (C) un examen histologique
- (D) un examen sérologique
- (E) des tests épicutanés

Réponse : D Examen sérologique

Examen sérologique de sypphilis. Lésions palmaires, squameuses, érythémateuses.

II

Q12

Question 12

Un homme de 64 ans se présente à votre consultation avec un nodule près du nez, qu'il a remarqué depuis une année. Quelle est la mesure la plus importante à prendre ?



- (A) anamnèse plus approfondie
- (B) palpation du nodule
- (C) dermatoscopie
- (D) **biopsie**
- (E) excision avec une marge de sécurité de 2 cm

Réponse : D Biopsie

DDx : **carcinome basocellulaire** ou **carcinome spinocellulaire** ou carcinome **mixte**.

Autres :

Pourquoi **pas excision** : Si on suspecte un basocellulaire, il faut être sûr du type histopathologique. **Si carcinome basocellulaire de type sclerodermiforme** ou mixte, on ne peut pas savoir le **niveau d'invasion** (verticale et longitudinale).

Dermatoscopie ne serait **pas efficace** car nodule sur le visage près du nez.

Q13

Question 13

A quelle maladie cutanée correspondent les lésions du visage illustrées ?



- (A) eczéma de contact
- (B) érysipèle → *unilat. et chaud (S. pyogènes)*
- (C) lupus érythémateux
- (D) lymphome
- (E) **rosacée** (*chaud, stress, off*) *Metronidazole*

Réponse : E

Autres :

Érysipèle : plutôt sur un côté + chaud à la palpation.

Lymphome : moins bien délimité.

Q14

Question 14

Au cours des 10 dernières années, une femme de 80 ans a développé une tumeur paranasale droite, qui saignait parfois d'une façon spontanée. Quel est le diagnostic le plus probable ?



- (A) carcinome basocellulaire
- (B) histiocytofibrome
- (C) mélanome nodulaire amélanotique
- (D) carcinome spinocellulaire
- (E) fibroxanthome atypique

Réponse : A carcinome basocellulaire

Les petits vvx = prolifération cellulaire basaloïde en périphérie + centre ulcéré = typique du basocellulaire.

Autres

Histiocytofibrome : plutôt sur les jambes.

Q15

Question 15

Un homme de 49 ans vous consulte pour un contrôle général (check-up). En l'examinant, vous remarquez sur le dos une lésion qui mesure entre 6 et 10 mm de diamètre. Quelle est ensuite la démarche la plus appropriée?



- (A) excision de la totalité de la lésion pour l'examen histologique
- (B) ~~biopsie~~ pour examen histologique
- (C) radiothérapie
- (D) contrôle dans 3 mois
- (E) aucune des mesures susmentionnées

Réponse : A Excision de la totalité de la lésion pour l'examen histologique.

Dx : mélanome. Que ne fait-on pas en cas de suspicion de mélanome ? Réponse : biopsie. On l'excise d'emblée puis on envoie en patho. Selon le dx patho, les marges etc...

→ Deuxième reprise chirurgicale.